2026 年度安寧緩和醫學專科醫師訓練核心課程
-醫師專業進階課程(北區)

末期照顧的品質指標

講座日期：2026年07月18日(星期六) 10:30-11:20

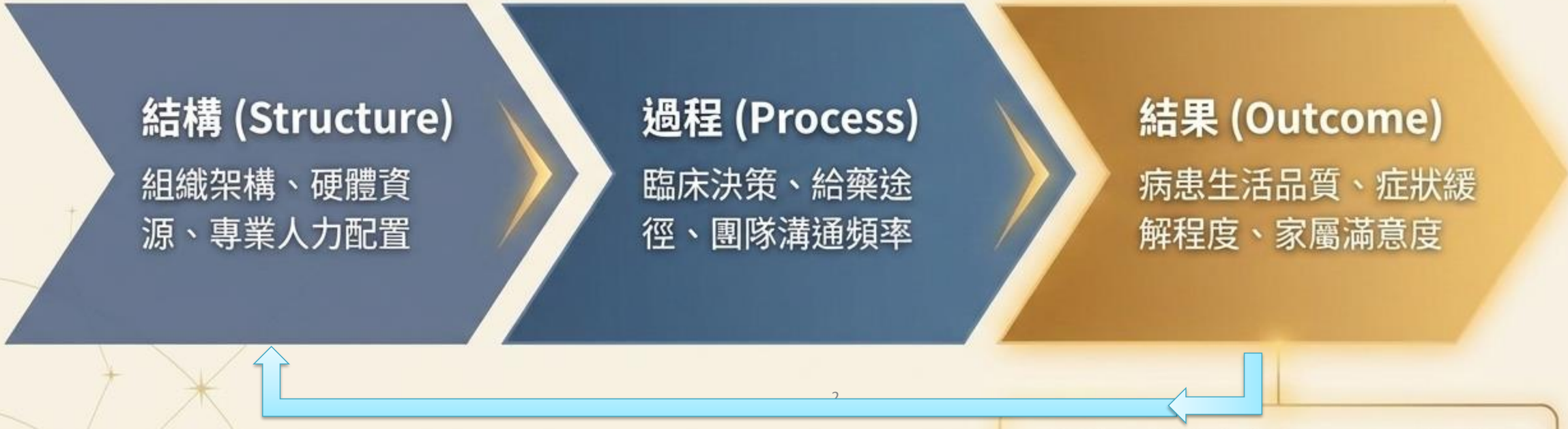
主　講　者：臺北榮總家庭醫學部林明慧主任

地　　點：IEAT會議中心9樓第1會議室

CC BY NC ND

透過 Donabedian 模式確立醫療品質的科學評估路徑

病人結果會受到疾病嚴重度與個案組合影響



結果回饋至結構與流程改善

挑戰：結構與過程可見，但『結果』該如何精準測量與對標？

實現全人善終：五大核心品質領域

臨床醫療與決策自主



症狀管理與解脫

協助病患從身心靈的痛苦中獲得緩解。



符合目標的治療與避免不合宜醫療

將生命最後階段還給病患。



共同決策、資訊理解與選擇受到尊重

支持病患參與醫療決策，使其保有尊嚴並做好準備。

心理負擔與關係維繫



減輕多重負擔

降低心理壓力、法律與經濟事務對家屬及社會的影響。





強化關係與好好告別

在身心平順的狀態下，完成生命中最後的連結。

現代安寧評估的臨床矛盾



- 病況快速變化
- 病人評估負荷



動態變化

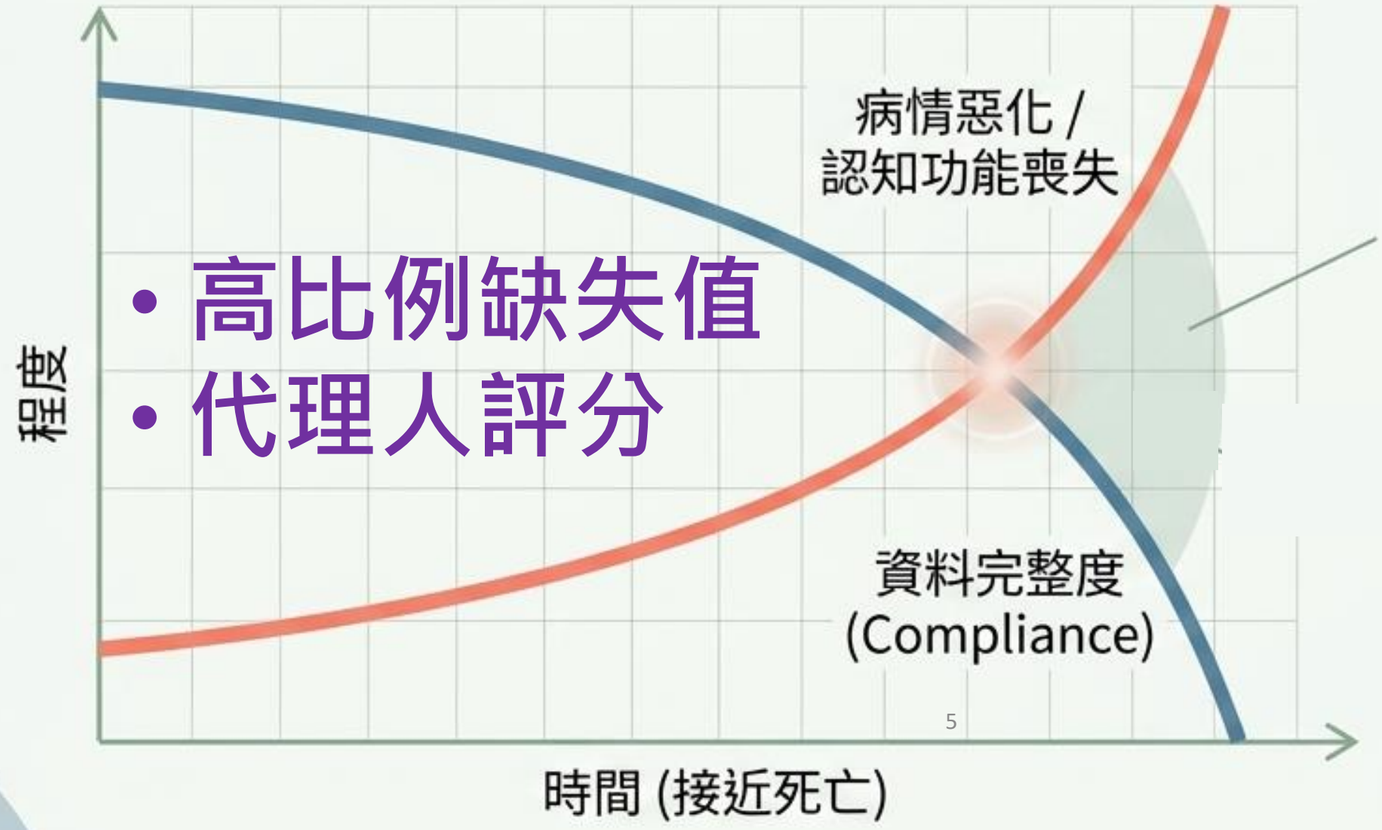
安寧病患病情變化迅速，要求量表必須對臨床變化具備高度敏感性。

極易疲倦

末期病患體力衰退，傳統冗長的多面向紙本問卷會造成嚴重的填寫負擔。

底層挑戰：如何在不增加病患負擔的前提下，實現全面、即時且精準的臨床與研究評估？

臨床限制：末期評估的資料遺失挑戰



隨著時間推移，病患病情迅速惡化。

資料缺失原因包括失能、譫妄、照顧者代答與死亡

ESAS愛德蒙頓症狀評估系統
(Edmonton Symptom Assessment Scale)

ESAS

過去24小時內症狀評分、 0~ 10分（最嚴重）

患者或家屬自評 、適合重複追蹤

1.疼痛 (Pain)
2.疲勞 (Tiredness)
3.困倦 (Drowsiness)
4.噁心 (Nausea)
5.食慾 (Appetite)

6.抑鬱 (Depression)
7.焦慮 (Anxiety)
8.氣促 (Shortness of breath)
9.幸福感 (Wellbeing)
10.睡眠障礙

其他（依各機構表單調整，常加上便秘或腹瀉等）

STAS（The Support Team Assessment Schedule)安寧療護臨床品質稽核問卷

STAS

症狀8題*社心4題*溝通2題

(一)疼痛對您所照護病患之影響：

0:無疼痛現象。

1:偶而才痛一下，尚不至於因疼痛而感覺困擾。

2:疼痛已造成困擾，並因而限制了部份日常活動。

3:時常發生嚴重疼痛，而使病患的活動與注意力明顯

4:持續不斷的嚴重疼痛，干擾病患思緒而無法想其他

(二)便秘狀況：

0:無便秘現象。

1:偶而出現一些便秘症狀，尚不至於因便秘而感覺困

2:便秘已造成困擾，並因而限制了部份日常活動。

3:時常發生嚴重便秘、而使病患的活動、注意力及生

4:便秘現象很嚴重持續不斷，令病患難以忍受。

(三)噁心、嘔吐狀況:

0:沒有噁心、嘔吐現象。

1:偶而出現一些噁心、嘔吐症狀，尚不致使病患受困

2:噁心、嘔吐已造成困擾，並因而限制了部份日常活

3:時常發生嚴重噁心、嘔吐、而使病患的活動、注意

4:持續不斷嚴重噁心、嘔吐，干擾思緒且無法從事其

(四)食慾狀況:

0:食慾維持正常。

1:偶而才出現幾次食慾不佳現象。

2:食慾不佳現象已造成困擾，並因而限制了部份日常

3:時常發生嚴重食慾不佳，而使病患的活動、注意力

4:持續不斷嚴重食慾不佳。

(五)呼吸困難狀況：

(十)您所照顧病患對自己病情之了解及準備:

0:完全知道自己之病情進展，並對即將面臨的身體變化做好準備。

1:對於病情進展應該大概知道一半以上。

2:不確定。

3:估計自己應有復原機會，甚至還可以再工作一段時間。

4:認為此次住院治療將有助於完全痊癒。

(十一)身為病患最親近的主要照顧者，您是否亦出現焦慮現象？

焦慮時可能伴隨之生理反應：如心悸、顫抖、手心出汗、頭昏、手腳發麻等症狀。

0:沒有焦慮狀況。

1:偶而對一些變化會擔心、緊張，且顯出焦慮症狀(如上所列)，但注意力未受影響。

2:對即將面臨的變化與問題，產生焦慮的生理反應，並因而影響了部份的生活作息。

3:經常性焦慮，且已明顯影響您之思緒及注意力。

4:持續嚴重地、完全地陷在焦慮的情緒，無法想別的事。

(十二)您所照顧病患與你們（或親友）間溝通的深度及開放情形

0:很滿意。

1:大部分時間還算滿意。

2:普通。

3:不太滿意。

4:很不滿意，希望能更好。

(十三)你對團隊成員（包含醫師、護理師社工及志工等人員）與家屬、病患間的溝通情形:

0:很滿意。

台北榮總安寧療護共同照護結果品質稽核量表

		填寫時機 / 填寫日期	收案時	第一週	第二週	第三週
		（結案日期：　/　/　）				
1. 在最近的三天裡，病人是否為**疼痛**所影響?	0.沒有影響 1.輕微,尚未造成病人困擾 2.中度,並限制病人部分活動 3.嚴重,限制大部分活動，並造成困擾。 4.很嚴重,明顯影響病人活動或注意力。		0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐
2. 在最近的三天裡，病人是否因**便秘**造成困擾?	0.沒有影響 1.輕微,尚未造成病人困擾 2.中度,並限制病人部分活動 3.嚴重,限制大部分活動，並造成困擾。 4.很嚴重,明顯影響病人活動或注意力。		0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐
3. 在最近的三天裡，病人是否因**其他症狀**造成困擾？ 請寫下症狀：	0.沒有影響 1.輕微,尚未造成病人困擾 2.中度,並限制病人部分活動 3.嚴重,限制大部分活動，並造成困擾。 4.很嚴重,明顯影響病人活動或注意力。		0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐
4. 在最近的三天裡，病人是否因**焦慮或憂鬱**造成困擾？	0.沒有影響 1.偶而。 2.有時候，且會影響其注意力。 3.大多數時間會，且常會影響其注意力。 4.很嚴重,明顯影響病人無法思考其他事		0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐

POS

症狀3-4題
社心3-4題
溝通2題

POS
www.pos-pal.org

For staff use
Patient number:

IPOS Patient Version

www.pos-pal.org

Name: .....

Date (dd/mm/yyyy): / /

Please write clearly, one letter or digit per box. Your answers will help us to keep improving your care and the care of others.

Thank you.

Q1. What have been your main problems or concerns over the past 3 days?

1. _____
2. _____
3. _____

Q2. Below is a list of symptoms, which you may or may not have experienced. For each symptom, please tick the box that best describes how it has affected you over the past 3 days.

症狀10題

	Not at all	*Slightly*	*Moderately*	*Severely*	*Overwhelmingly*
Pain	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Shortness of breath	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Weakness or lack of energy	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Nausea (feeling like you are going to be sick)	0				4 ☐
Vomiting (being sick)	0				4 ☐
Poor appetite	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Constipation	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Sore or dry mouth	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Drowsiness	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Poor mobility	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

Please list any other symptoms not mentioned above, and tick the box to show how they have affected you over the past 3 days.

1.	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
2.	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
3.	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

Over the past 3 days:

情緒3題

	Not at all	*Occasionally*	*Sometimes*	*Most of the time*	*Always*
Q3. Have you been feeling anxious or worried about your illness or treatment?	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Q4. Have any of your family or friends been anxious or worried about you?	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Q5. Have you been feeling depressed?	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

心理平安3題

	Always	*Most of the time*	*Sometimes*	*Occasionally*	*Not at all*
Q6. Have you felt at peace?	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Q7. Have you been able to share how you are feeling with your family or friends as much as you wanted?	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Q8. Have you had as much information as you wanted?	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

實務1題

	Problems addressed/ No problems	*Problems mostly addressed*	*Problems partly addressed*	*Problems hardly addressed*	*Problems not addressed*
Q9. Have any practical problems resulting from your illness been addressed? (such as financial or personal)	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

	On my own	*With help from a friend or relative*	*With help from a member of staff*
Q10 How did you complete this questionnaire?	☐	☐	☐

i POS

初入院
3天後
1周後

iPOS比單純症狀量表更能整合病人關切、症狀與心理社會需求。

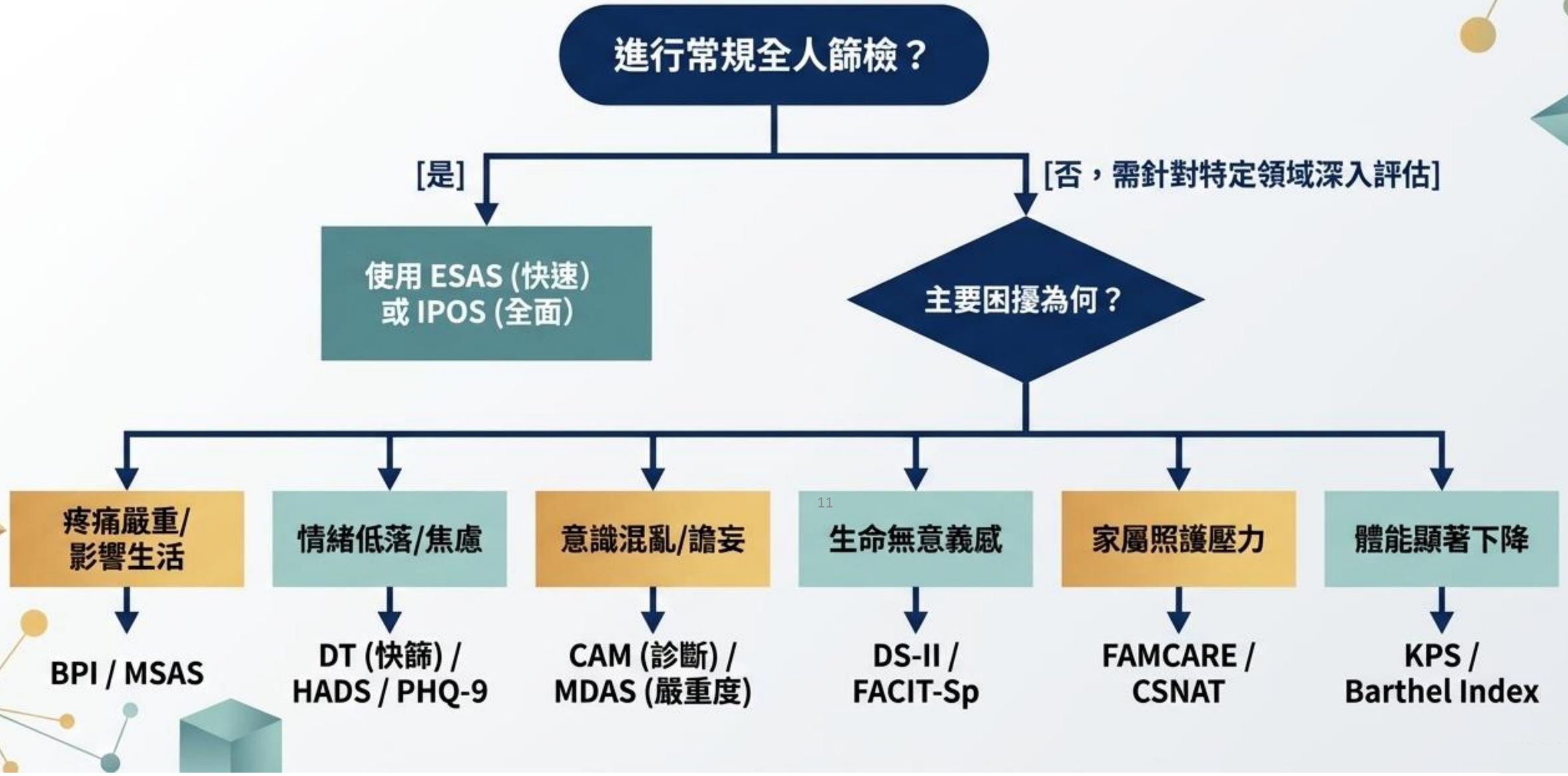
核心綜合評估工具比較

IPOS是廣泛驗證、兼顧症狀與心理社會需求的多面向工具之一

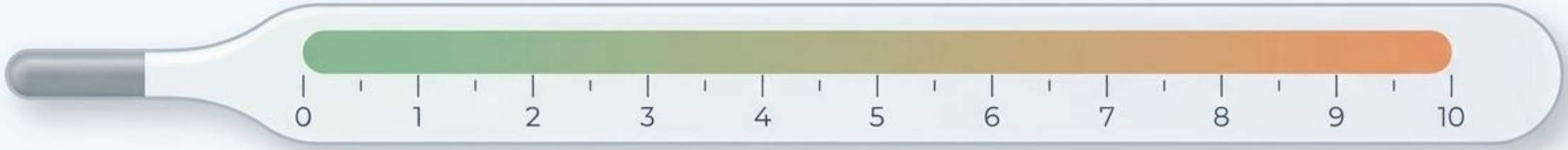
工具名稱	核心設計	關鍵特色	最佳適用場景
ESAS (艾德蒙頓症狀評估系統)	9-10個常見症狀 (0-10分 NRS) 病人自評	最簡短、易用、 廣泛驗證	快速常規症狀篩檢
POS / IPOS (安寧療護結果/整合版量表)	涵蓋生理/心理/ 家屬/資訊	具備病患、家屬與 工作人員多種版本	國際極力推廣之全方位 常規評估
EORTC QLQ-C15-PAL	萃取自 C30 癌症量表 表的 15 題版 病人自評	針對預期壽命較短者 減輕填寫負擔	臨床試驗與學術研究
MQOLQ (麥基爾生活品質問卷)	16個項目 病人自評	獨特納入「存在/靈性」 面向	深度評估整體生活品質
STAS (支持團隊評估量表)	專業人員填寫之檢核表 POS前身	聚焦臨床症狀與團隊/ 醫病溝通問題	團隊照護與溝通品質稽核

臨床選用建議 → 高頻率追蹤選 ESAS；跨域照護計畫選 IPOS；癌症臨床試驗選 EORTC。

臨床決策導航：評估工具選擇樹



篩檢不等於診斷 心理困擾篩檢的層次與速度



工具：DT（困擾溫度計） ≥4 作為進一步評估的參考

定位：【極速篩檢】

特色：單一視覺類比量表（VAS）搭配問題清單，以最快速度捕捉癌症病患心理困擾。

工具：HADS（醫院焦慮及憂鬱量表）

定位：【非精神科專用】

特色：14 個項目，專為一般醫療環境設計，快速篩檢焦慮與憂鬱狀態。

工具：PHQ-9（病人健康問卷）

定位：量化憂鬱嚴重度(切點:5/10/15/20)

特色：9 個項目，專注於精準評估憂鬱嚴重程度。便於轉介溝通與治療追蹤。

臨床警訊:末期病人多重身體症狀易與憂鬱重疊,需與臨床訪談並讀,避免將疲倦或疼痛誤判!

譫妄與認知功能的診斷階層

有沒有譫妄？

Step 1: 診斷確認 → CAM

聚焦：急性發作、注意力不集中、意識改變。
優勢：高敏感度與特異度，適合列入護理或醫師的常規評估。

譫妄多嚴重？

Step 2: 量化追蹤 → MDAS

聚焦：10 題臨床人員評分（0-30分）。
優勢：精確追蹤嚴重度變化，適合評估藥物或介入成效。

基礎認知如何？

Step 3: 背景能力 → MMSE

聚焦：定向感、記憶、語言等整體認知（最高30分）。
限制注意：對譫妄波動不敏感；深受病人疲倦程度影響。

混亂評估方法　紀念醫院譫妄評估量表　簡易心智狀態量表

“當症狀控制良好，但病人依然極度痛苦，單用 ESAS 或 PHQ-9 已然不足。”

- *DS-II 協助釐清他的靈性枯竭*

我不是痛,我是活得没有意義
我不想拖累家人。



士氣喪失 (Demoralization)
➜ DS-II

16 題。評估失去意義、無望、求死意念。比一般憂鬱量表更貼近末期病人的存在困擾 (Existential distress)。



靈性福祉（Spiritual）
FACIT-Sp（慢性病靈性量表）

少於 5 分鐘。評估意義、平安、信仰支持。國際通用，不限單一宗教。(需以文化敏感方式說明)



生命意義 (Life Meaning)
➜ MQOL

能將生理症狀與整體生命意義、存在品質完美整合的工具。

- 存在面向專家。當發現病患生理症狀平穩，卻依然眼神空洞時，MQOLQ 能探索他內心的存在危機

照護歷程與家屬經驗的時間軸對應

不同時間點，不能用同一份問卷處理

居家/病房照護進行中

CSNAT (照顧者支持需求)

- **時機**：居家照護、出院銜接、病情惡化時。
- **目的**：預防照顧者崩潰。以照顧者需求為中心，直接引導支持計畫介入。

照護滿意度回饋

FAMCARE

- **時機**：照護期間或死亡後。
- **目的**：評估家屬對資訊提供、症狀控制與整體服務的滿意度。適合用於安寧團隊品質改善。

病人死亡後

GDI (Good Death Inventory)

- **時機**：病人死亡後，由喪親家屬回顧。
- **目的**：好死品質評估。捕捉終環境舒適、生命圓滿、不成為負擔等「好死」特徵。

109年衛福部
臺灣癌症與非癌症緩和療護
品質監測試辦計畫(PCOC)



臺灣安寧緩和療護
品質管理計畫
Taiwan Palliative Care
Outcome Collaboration

臨床實務手冊
Clinical Manual

(第二版)
2021.0.08 修訂
2021.08.22

PCOC (since 2005)

Palliative Care Outcomes Collaboration

由澳洲政府委託學界研發，在澳洲以及全球已經推動10餘年的安寧緩和療護品質監測計畫

系統性的導入有效的**臨床評估**工具，成為常規臨床評估每位接受安寧緩和服務病人的經驗

透過臨床數據收集，呈現病人疾病軌跡（disease trajectory）及**病人照護結果**，並可作為提升病人照護品質之工具

PCOC 生態系徹底顛覆傳統單向的評估量表思維

傳統量表思維	PCOC 臨床生態系
資料收集：單一量表、孤立數據	**資料收集**：涵蓋五大維度的臨床評估生態系
運作機制：單向填寫、事後回顧	**運作機制**：臨床現場 (Point-of-care) 高頻運作
團隊溝通：各自表述的觀察	**團隊溝通**：多專科團隊的「共同語言」
品質驅動：無外部對照	**品質驅動**：國家級品質稽核平台

五大經國際驗證的核心工具，為跨專科團隊建立共同語言

核心引擎：臨床團隊判定 (Clinician Assessed)

Phase
(安穿療護階段)

判斷穩定、不穩定、惡化或臨終，決定介入緊急度（指標：不種定期是否能在 3 天內改善）。

PCPSS
(問題嚴重度量表)

評估疼痛、其他症狀、心理/靈性、家屬/照照者問題等四大範鳴（0-3分）。

AKPS
(澳洲版卡氏體能)

快速精準定位日常體能與進化進程。

RUG-ADL
(日常生活活動能力)

評估進食、移動、如前依賴度，驅動照護資源精準投放。

19

即時醫療決策

核心引擎：病患/家屬自評 (Patient/Family Assessed)

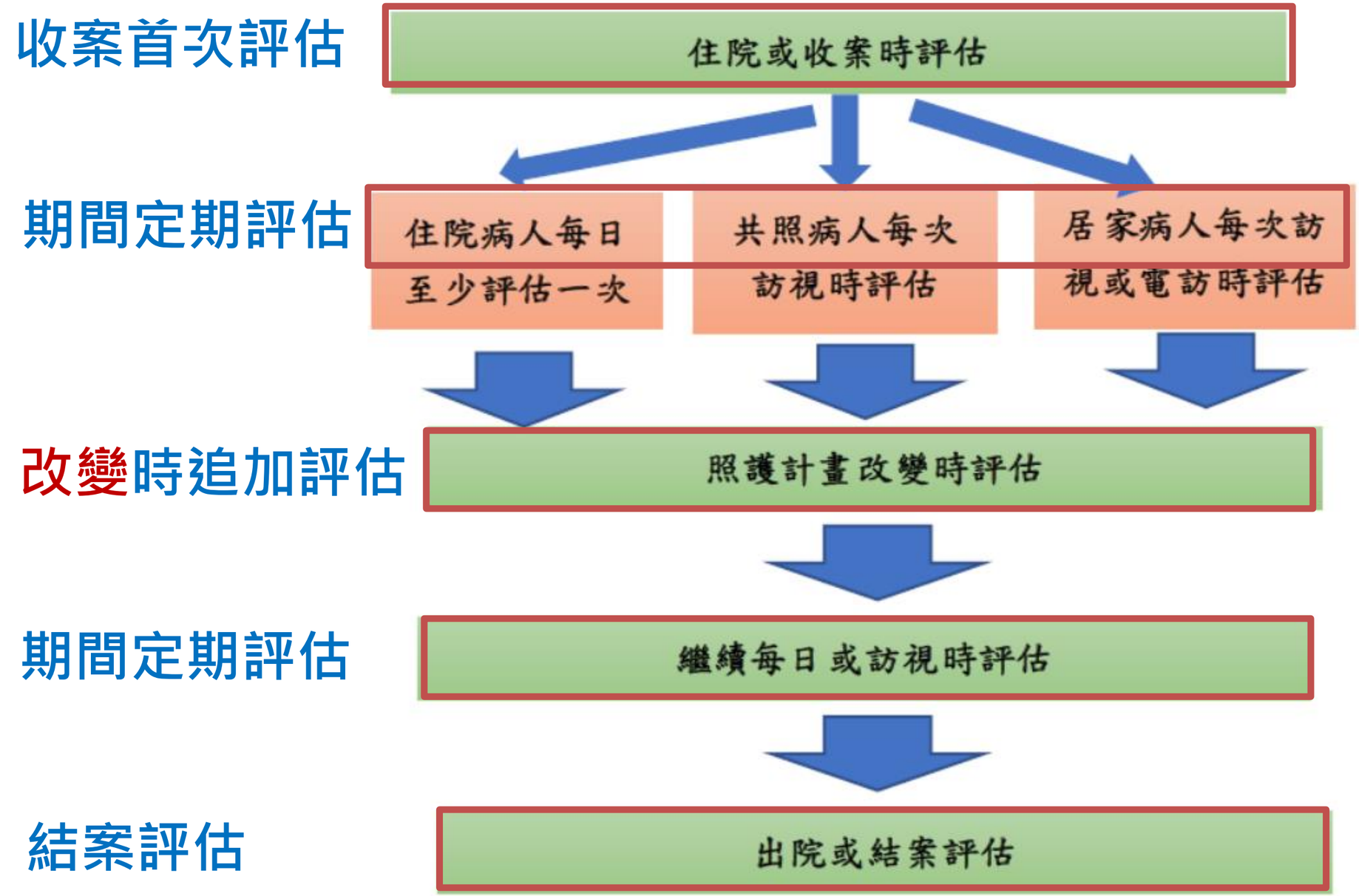


SAS (症狀評估量表)

7 項常見身體症狀的囲優程度自評（0-10分）。

2026年：V4版 原 SAS (7+1項) 已替換為 (11+1項)

安寧緩和療護五項評估工具使用方法



資料來源：臺灣安寧緩和療護品質管理計畫臨床手冊v2_20210822

PCOC評估表 (共20個欄位)

1. SAS
病家評分

可能有
Missing值

ＳＡＳ症狀困擾評估: 評分者: 病人 家屬 看護 全數不適用

睡眠困擾	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
食慾困擾	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
噁心嘔吐	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
腸胃不適	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
呼吸困難	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
倦怠疲憊	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
疼痛	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
其他	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A

病人或家屬覺得有多困擾？

2.PCPSS
團隊判斷問題有多嚴重？

ＰＣＰＳＳ需求評分

疼痛	0	1	2	3
其他症狀	0	1	2	3
社會/心理/靈性	0	1	2	3
家屬/照顧者	0	1	2	3
舒適護理	0	1	2	3

3.RUG-ADL
日常照護需要多少人力？

ＲＵＧ－ＡＤＬ評分

					參考評分標準
床上活動	1		3	4	5	
如廁	1		3	4	5	
移位	1		3	4	5	
進食	1	2	3			
總分						

整體功能與疾病進程如何？

4.AKPS

AKPS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

5.Phase

Phase	1	Stable	2	Unstable	3	Deteriorating	4	Terminal

病人目前處於何種照護狀態？



1.SAS (類似ESAS)對話
(對病人、家屬或照顧者)

- 從昨天到現在讓你最感病人不舒服或困擾的症狀是什麼？
- 你覺得最先要處理的是什麼？
- 你最在意的是什麼? 困擾的點是甚麼? 有多困擾? (0 – 10分)
- 昨天問你的症狀今天覺得如何？
- 有其他新的症狀困擾你嗎?

2.PCPSS　醫療團隊對PCPSS評估的臨床回應與處置建議

1.疼痛

2.其他症狀

3.社會/心理/靈性

4.家屬/照顧者

5.舒適護理

分級		PCPSS 臨床情況描述	PCPSS 臨床回應與處置建議
0分	沒有問題	★沒有症狀或問題	★維持現行照護計畫。
1分	輕微問題	★有輕微症狀或問題，但不影響病人照護 ★按照目前的照護計畫，問題有在處理中。	★**持續監測**與記錄待處理問題，並繼續現行照護計畫。 ★跨專業團隊會議**討論追蹤**相關狀況和問題。
2分	中等問題	★有中等程度症狀或一個以上的待處理問題，影響病人照顧。 ★問題可能是新發生或原來就有的。	★跨專業團隊重新檢視目前的照護計畫，制定解決問題的策略。 ★依評估與團隊共識，**調整、修改、或新增照護計畫相關內容、轉介、照會等**。
3分	嚴重問題	★有嚴重症狀或問題，正嚴重影響病人照護。 ★急性新發生的問題、或原來就有的問題惡化。	★需要**即時回應、緊急處置**。 ★跨專業團隊立即檢視、修改、調整照護計畫，發展出待處理問題的**解決策略** ★後續追蹤因應策略處置是否有讓問題減少與改善。

3. RUG-ADL

RUG-ADL		資源耗用分群-日常生活功能	臨床回應指引 (RUG-ADL : 4-18)
床上活動 如廁 移位	1	可獨立或在監督下完成	總分 4-5 分：持續觀察監測 總分 6-13 分：需要 1 個照顧人力, 注意有跌倒與壓傷的風險 總分 14-17 分：需要 1 個照顧人力, 且 ● 需建議輔具並視需要轉介 ● 需評估人員照護需求與照顧者負擔 ● 需跌倒危險評估 ● 需壓力性損傷危險評估, ● 需檢視跨團隊計畫/個案/家庭會議 總分 18 分：如上, 且需 2 個照顧人力
	3	需有限度協助	
	4	需 1-2 人身體協助	
	5	需 2 人以上身體協助	
進食	1	可獨立或在監督下完成	
	2	需有限度協助	
	3	需大部份協助/完全依賴/管灌	

4.AKPS　AKPS 測量病人執行平日活動的能力 評估整體功能與預後

AKPS	澳洲版卡諾夫斯基功能狀態量表定義	臨床回應指引
100	正常，沒有不舒服或疾病	持續觀察,考慮與病人或家屬討論 ACP （AKPS 分數顯著降低 2 個類別以上時，建議評估是否需改變照護計畫和介入措施包括：轉介、檢視照護計畫、召開個案/家庭會議等）
90	可以正常活動，輕微的疾病症狀或徵兆	
80	勉強正常活動，有些許疾病症狀或徵兆	
70	生活可以自理，無法維持正常活動或工作	
60	生活有時需要協助，但大多數時間可自理	
50	生活需要別人協助，且經常需要醫療照護	建議多科團隊共同檢視： ● 提供適當輔具及進行危險評估 ● 照護需求評估或召開個案/家庭會議
40	臥床時間超過 50%	建議多科團隊共同檢視： ● 提供適當設備以避免壓傷 ● 社區病人需完成照顧者負擔評估
30	幾乎完全臥床	
20	完全臥床，需要專業人員或家屬照護	啟動生命末期照護，若病人可能在幾天內死亡,則改判病人為臨終期。
10	昏迷或是幾乎叫不醒	

Ref: PCOC assessment & response protocol, ahsri.uow.edu.au, 2016

5.Phase：stable - unstable - deteriorating - terminal

症狀評估總分定義與臨床回應與緩和照護 Phase 判定建議				
症狀評估嚴重度			臨床回應指引	緩和照護 Phase
嚴重程度	SAS	PCPSS		
無症狀	0	0	持續目前照護計畫/建議出院	Stable 或 terminal
輕微症狀	1-3	1	持續觀察、監測和記錄/在多科團隊討論	Stable/ Deteriorating 或 terminal
中度症狀	4-7	2	*MDT 檢視/改變照護計畫：視需要轉介社工,靈性人員;提供設備,喘息服務或教育家屬等	Deteriorating 或 terminal
嚴重症狀	8-10	3	*需要 MDT 緊急介入處置/如安排住院,轉介諮商,家族治療,轉介家屬/照護者給醫療人員	Unstable 或 terminal

*指需要多科團隊(MDT)定期檢視照護計畫並發展問題解決策略

PCOC評估表資訊化鍵入示意圖 (共20個欄位)

新版 ESAS-PCOC (11+1)

睡眠困擾

缺乏食慾

噁心

便祕

呼吸困難

疲倦（缺乏精力）

嗜睡（感覺睏倦）

疼痛

憂鬱（感到悲傷）

焦慮（感到緊張）

整體感受

其他:口乾或癢，混亂，吞嚥問題

……

SAS症狀困擾評估: 評分者: 病人 家屬 看護 全數不適用

睡眠困擾	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
食慾困擾	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
噁心嘔吐	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
腸胃不適	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
呼吸困難	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
倦怠疲憊	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
疼痛	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
其他	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A

PCPSS需求評分

疼痛	0	1	2	3
其他症狀	0	1	2	3
社會/心理/靈性	0	1	2	3
家屬/照顧者	0	1	2	3
舒適護理	0	1	2	3

RUG-ADL評分

床上活動	1		3	4	5
如廁	1		3	4	5
移位	1		3	4	5
進食	1	2	3		
總分	13				

參考評分標準

AKPS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Phase	1	Stable	2	Unstable	3	Deteriorating	4	Terminal

PCOC 安寧緩和照護Phase定義

109.8.3 版

安寧緩和照護Phase，表示是臨床上對病人的狀態具有意義的照護。安寧緩和照護Phase是經全人臨床評估，評定主要之考量是依照病人和家屬、照護者的需求。

Phase 開始共識	Phase 結束共識
1. Stable (穩定期)	**Monitor, review, anticipate & respond**
所有未分類為不穩定，惡化或末期的狀況，如： ▪病人的問題與症狀可由既有的照護計畫充分掌控。 ▪已有進一步的介入計畫，以維持症狀控制及生活品質。 ▪家屬/照顧者的狀態相對穩定，沒有新問題出現。既定的照護計劃，可滿足目前需求。	▪病人與/或家屬/照顧者的**需求增加，需要改變**現行的照護計畫或緊急處置(病人改判為不穩定期） ▪病人的**整體功能與現有症狀正在變差**/出現新問題或是家屬/照顧者的狀況惡化，尚不需要緊急處置時，病人將改判為惡化期。
2. Unstable (不穩定期)	**Urgent response required**
照護計畫需有緊急改變，緊急轉介或緊急處置，因 ▪病人出現**新的問題**，且非現有照護計畫能處理。 ▪病人現有問題的**嚴重度急速增加**。或 ▪家屬/照顧者情況突然改變，**需要**多科團隊成員的**緊急干預**。 **需 24 小時內再度評估審視**	▪新的照護計畫已經成形並經過審視，沒有需要進一步更改照護計劃。這並不意味著症狀/危機已完全解決，但**已有明確的診斷和照護計劃**(即病人改判為穩定期或惡化期) ▪病人可能在幾天之內死亡（即病人改判為臨終期）

Phase 開始共識	Phase 結束共識
3. Deteriorating (惡化期)	**Review & change care plan**
現有的照護計畫可以解決預期的照護需求。目前並不需要緊急處置，如： ▪病人整體的**功能狀況正在下降**。 ▪病人現有的**症狀正在逐漸惡化**。 ▪病人出現新的、但是預期中的問題。 需要定期審視或改變照護計劃以應對增長的需求。 ▪家屬/照顧者因病人的疾病，面臨**逐漸惡化的痛苦與困境**，包括社會或經濟實務的困難。需要增加提供支持和必要的諮詢。	經常審視並調整照護計畫，若 ▪當病人惡化趨於平穩(病人改判為穩定期)或 ▪照護計畫**發生巨大轉變或接受緊急治療**，且/或家屬/照顧者本身經歷了突然的變化，對病人照護產生影響，並且**需要緊急介入**措施。（亦即病人改判為不穩定期）。或 ▪病人可能在幾天內死亡（即病人改判為臨終期）
4. Terminal (臨終期)	**Monitor, review & respond**
▪**病人可能在幾天之內死亡**，且沒有計劃或必須進行任何緊急干預。病人此階段的典型特徵包括： •非常虛弱 •大多時間均臥床 •長時間昏沉狀態 •對時間的定向力出現混淆 •注意力嚴重受限 •對食物和水越來越不感興趣 •發現吞藥困難 •通常需要每天針對身體心理靈性提供照護服務。 •家屬/照護者認知死亡即將到來，並將關懷集中在心理情緒和靈性層面上，為喪親作準備。	▪病人死亡，或 ▪病人的狀況變化，幾天內不太可能發生死亡（即病人改判為穩定期、惡化期或不穩定期）

PCOC 團隊在職訓練

- 建立團隊評分共識
  - SAS/PCPSS 定義及評分標準介紹
  - RUG-ADL評分標準介紹
  - Phase定義、分級介紹
  - Phase評估分級問題討論
- 困難個案討論
- 安寧品質照護稽核技巧
  - 針對「PCPSS」稽核結果討論
  - 針對「Phase」稽核結果討論

白班每日
填寫一次

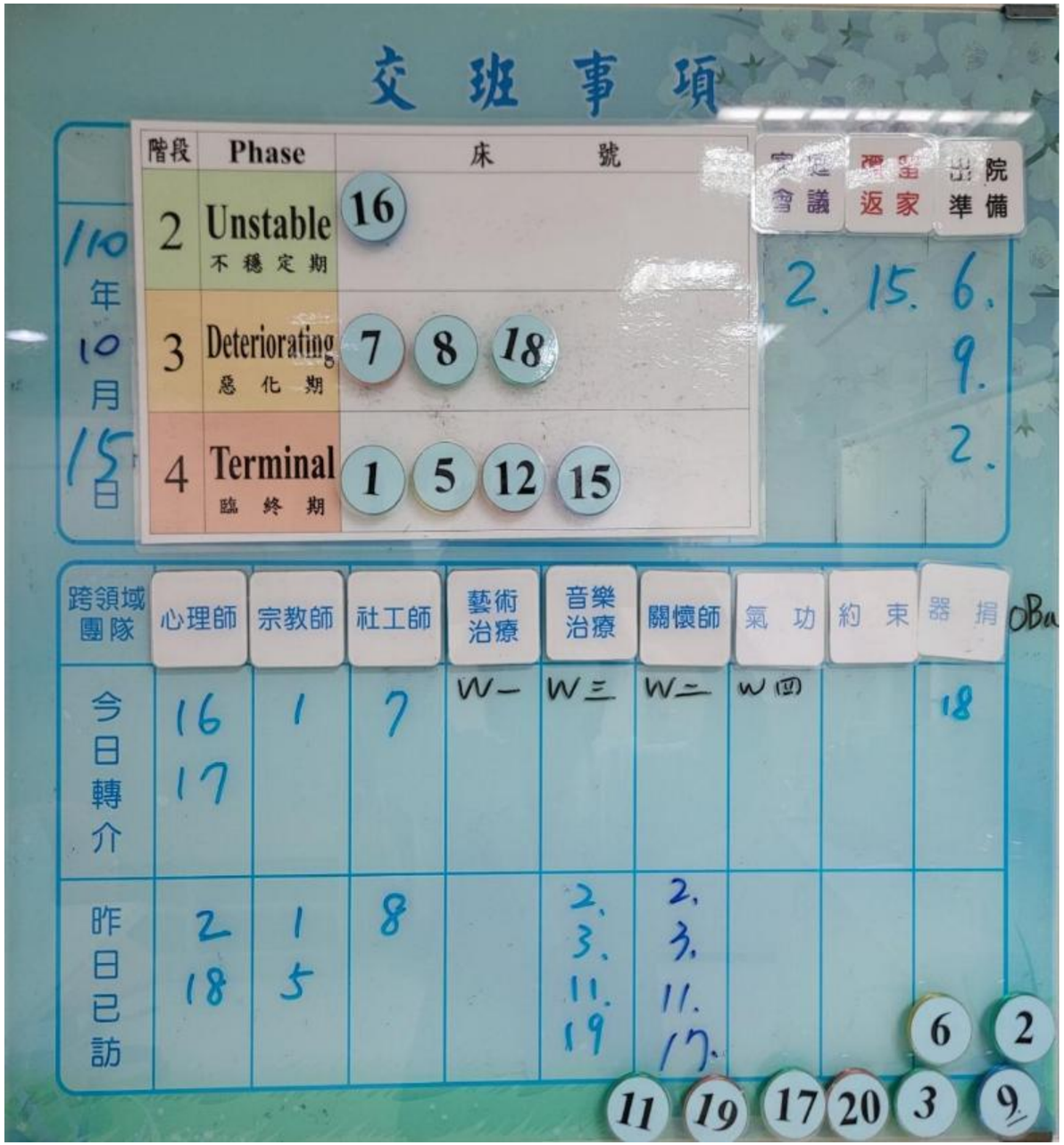
三班交班
互相提醒

病情變化
重新評估

晨會前呈
現PHASE
判定

晨會討論
確認共識

PCOC在
安寧病房
執行模式



PCOC記錄表單稽核工具

(Quality Improvement Audit)

CH2 對PCOC評估的回應稽核 (QI Audit Response to PCOC Assessments)	CH3 PCPSS評分稽核 (PCPSS QI Audit)
CH4 **Phase評估**稽核 (Phase Assessment QI Audit)	CH5 安寧療護**Phase變化**稽核 (Phase Change QI Audit)
CH6 **Phase定義**稽核 (Phase definition QI Audit)	CH7 SAS評估量表稽核 (QI Audit Patient _SAS)

運用PCOC進行緩和療護品質推動的優點

需要單位主管明確支持才能貫徹執行

呈現病人需要

標準定期評估

回應病人問題

服務評量識別

標竿追蹤比較

提升照護品質

PCOC評估結果可轉換成可比較的品質標準

有 20 個基準:

- 1 個 照護的即時性

90%的病人在啟動緩和照護當天或隔日開始接受到照護

- 1 個 對緊急需求的回應

90%的病人處於不穩定照護階段的時間少於3天

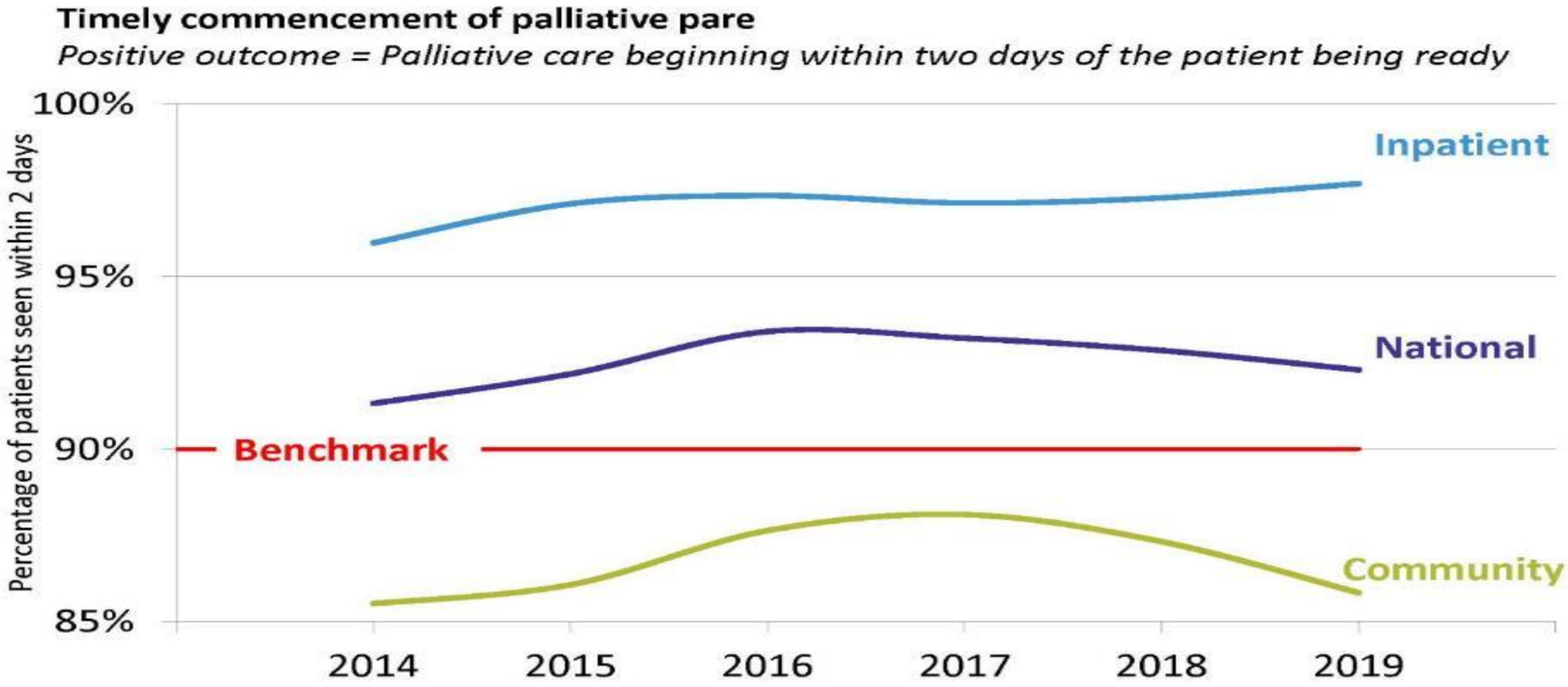
- 6 個 疼痛管理*
- 9 個 症狀管理*
- 3 個 家屬/照顧者問題*



指標1：及時接受安寧緩和療護

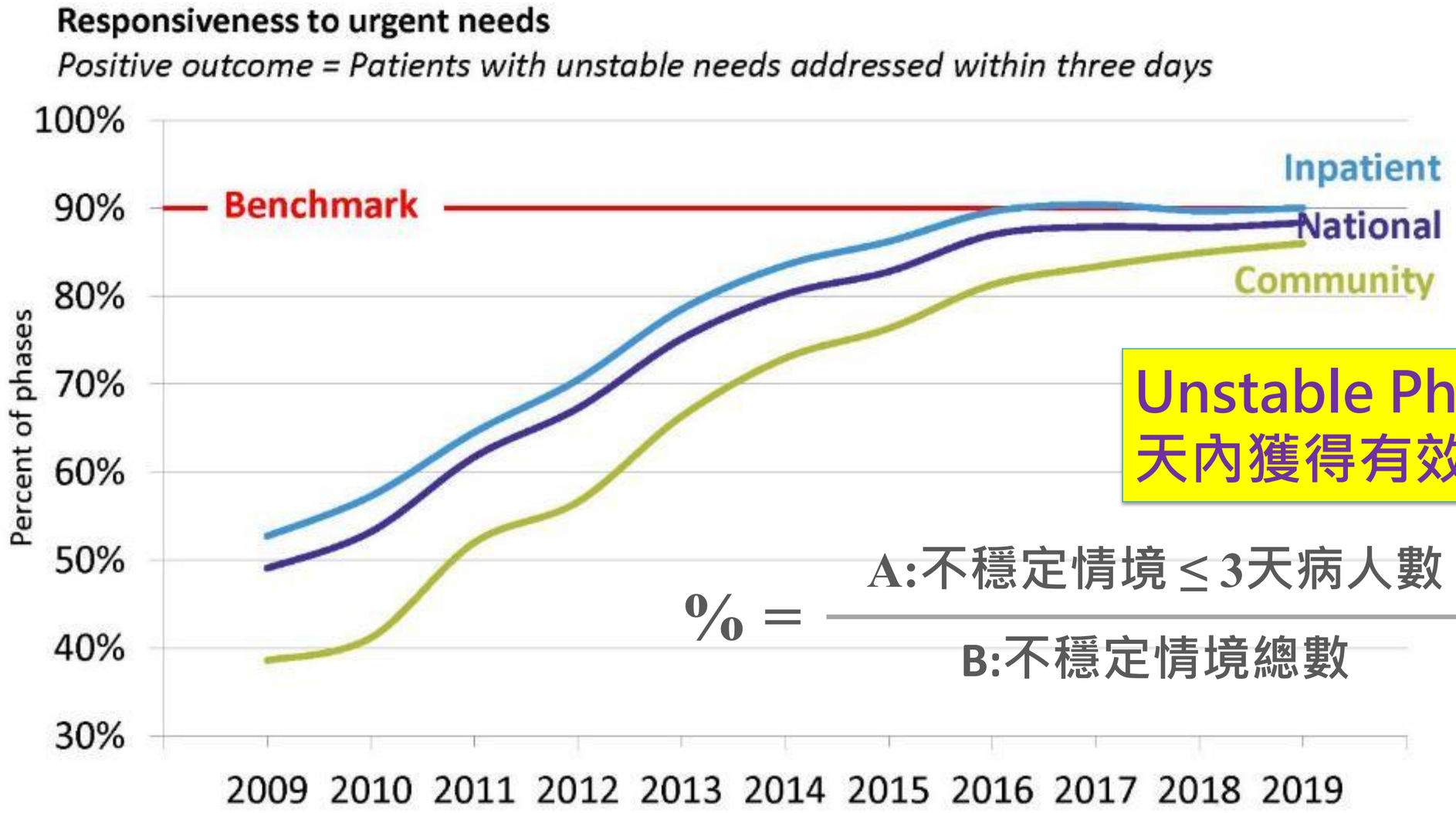
閾值定義：90%確認可接受安寧療護的病人到真正接受到服務的時間≤2天

$$\% = \frac{\text{A:收案日期減會診/排床日} \leq 2\text{天}}{\text{B:會診/排床人數}}$$



指標2：回應病人緊急照護的需求

閾值定義：90%不穩定情境的時間小於(等於)三天



Unstable Phase在三天內獲得有效回應

$$\% = \frac{\text{A:不穩定情境} \leq 3\text{天病人數}}{\text{B:不穩定情境總數}}$$

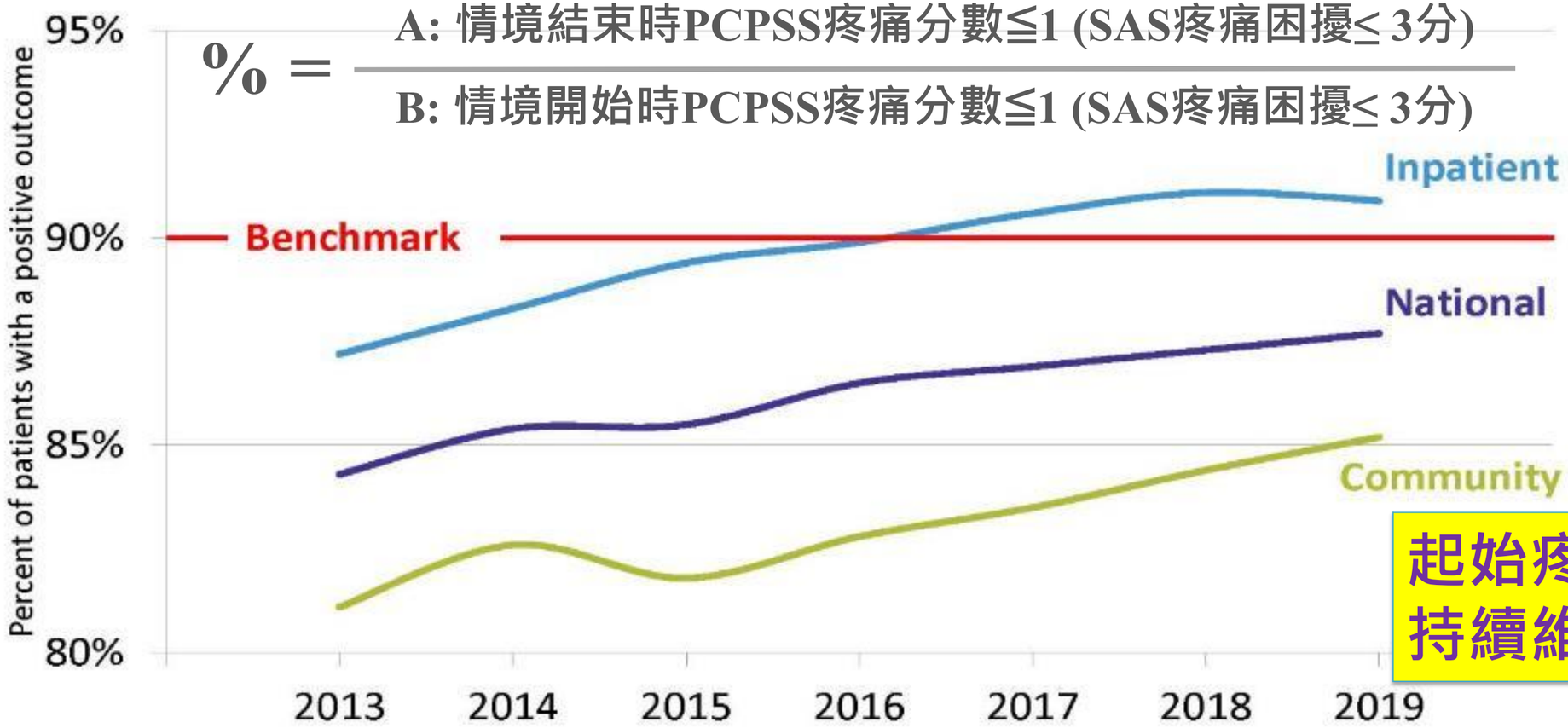
指標3.1：預期性照護-疼痛

閾值定義：90%病人在情境開始及結束時，PCPSS疼痛均維持≦1分 (SAS疼痛困擾均維持≤3分)

Anticipatory pain management

Positive outcome = Patients with absent or mild distress due to pain at the end of a phase (maintained that way from the beginning of the phase)

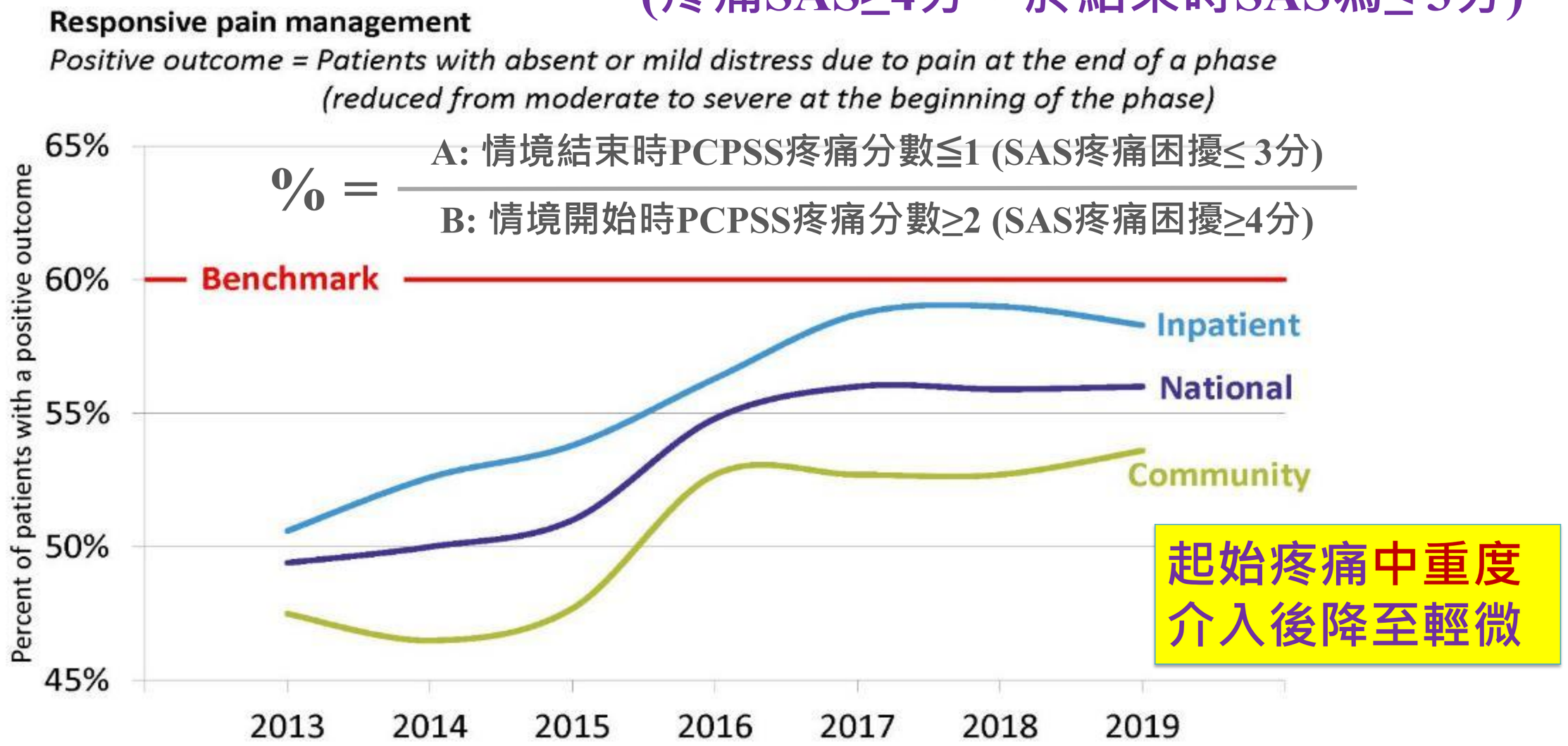
$$\% = \frac{\text{A: 情境結束時PCPSS疼痛分數≦1 (SAS疼痛困擾≤3分)}}{\text{B: 情境開始時PCPSS疼痛分數≦1 (SAS疼痛困擾≤3分)}}$$



起始疼痛輕微
持續維持低疼痛

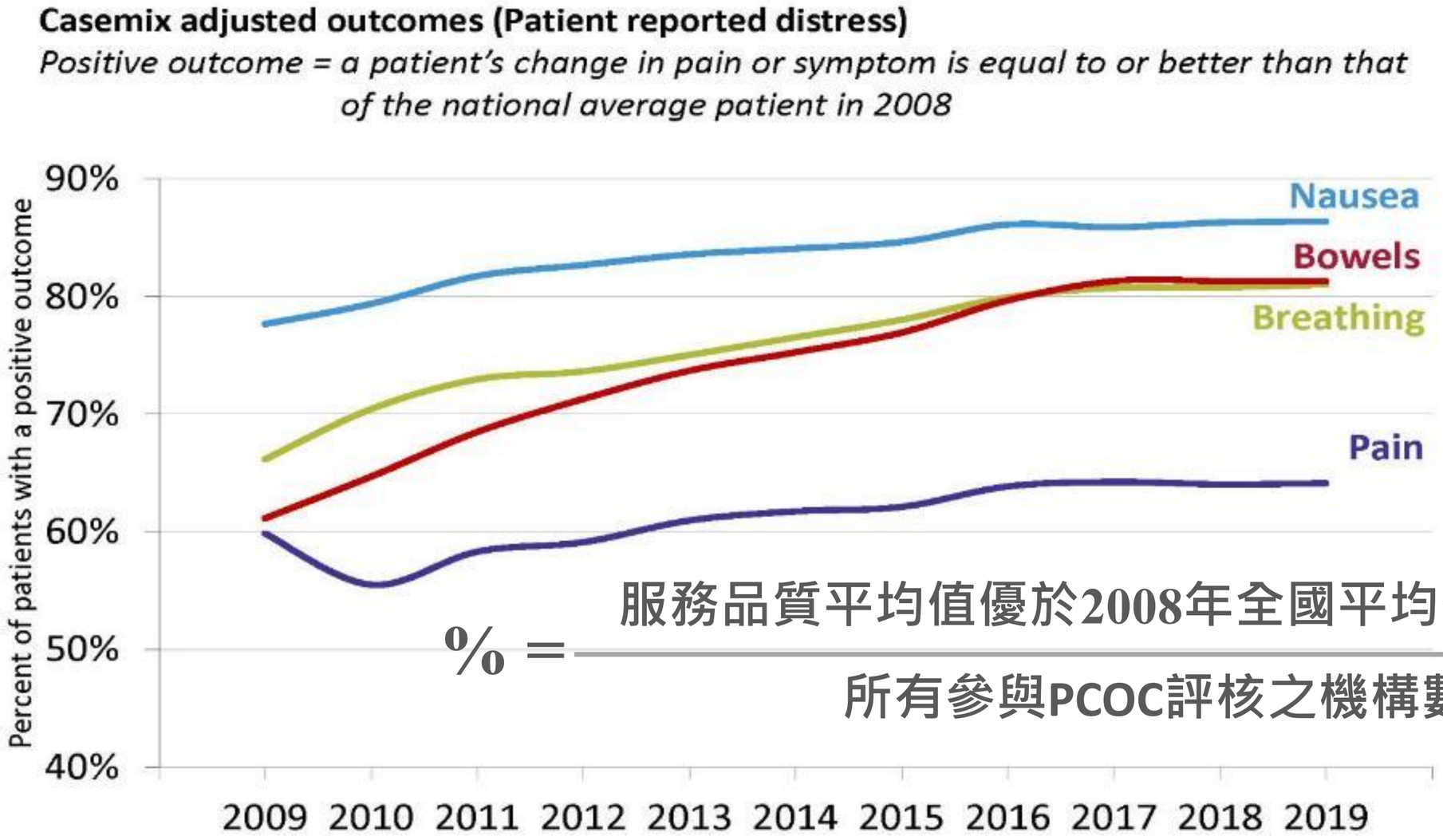
指標4.1：回應性照護-疼痛

閾值定義： 60%病人在情境開始時疼痛PCPSS≥2分,結束時PCPSS ≤1分 (疼痛SAS≥4分，於結束時SAS為≤ 3分)



指標5：進行案例組合調整後的照護成果測量

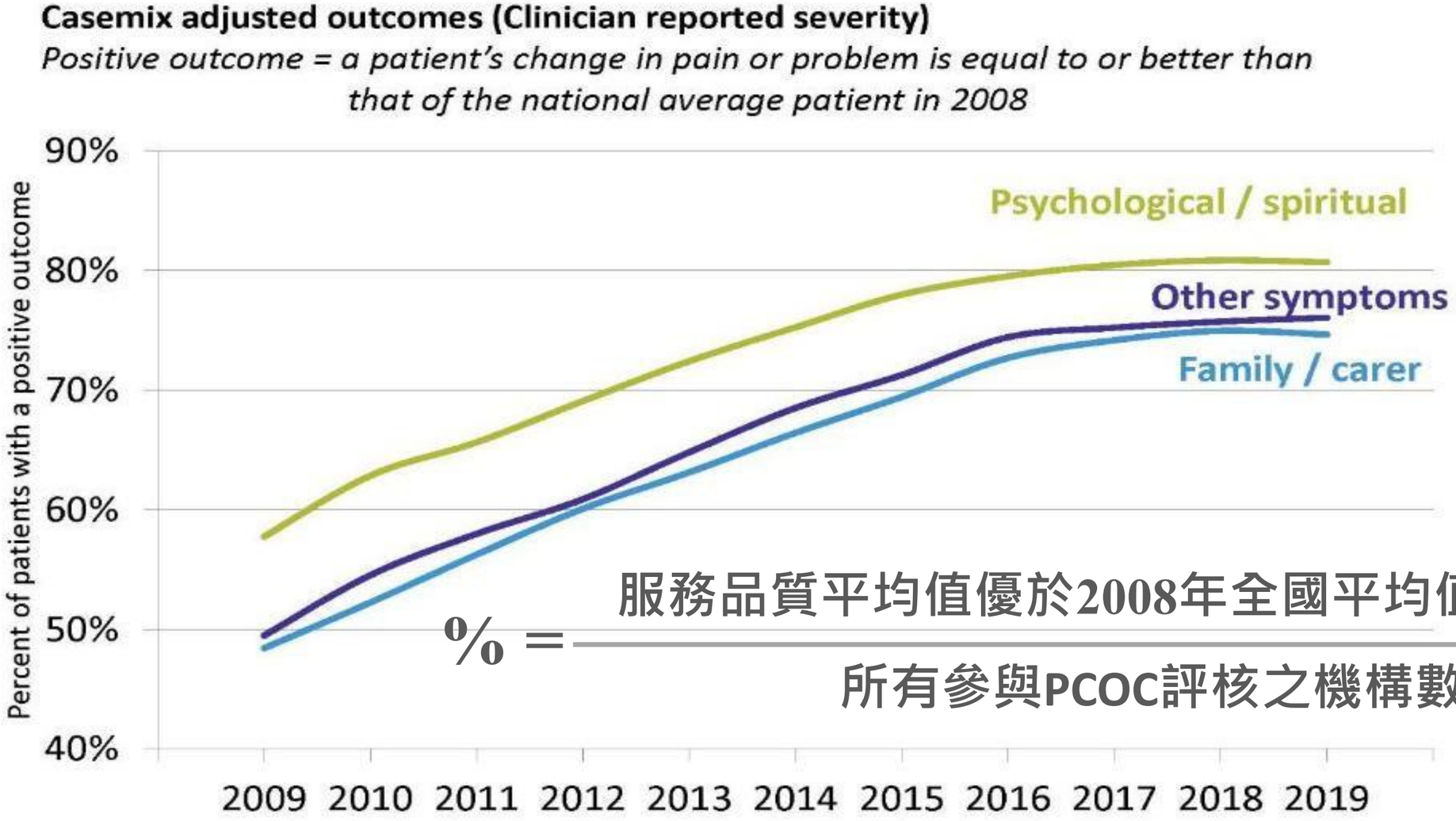
測量呈現平均得分優於2008年全國平均值的比例



$$\% = \frac{\text{服務品質平均值優於2008年全國平均值的機構數}}{\text{所有參與PCOC評核之機構數}}$$

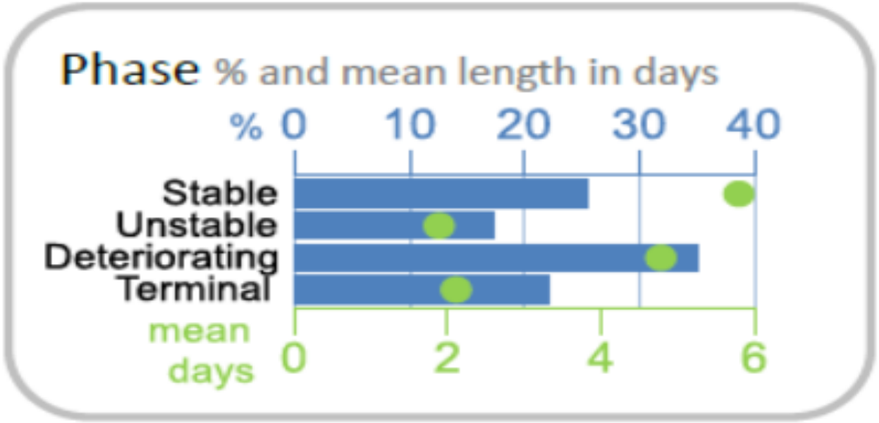
指標5：進行案例組合調整後的照護成果測量

測量呈現平均得分優於2008年全國平均值的比例



$$\% = \frac{\text{服務品質平均值優於2008年全國平均值的機構數}}{\text{所有參與PCOC評核之機構數}}$$

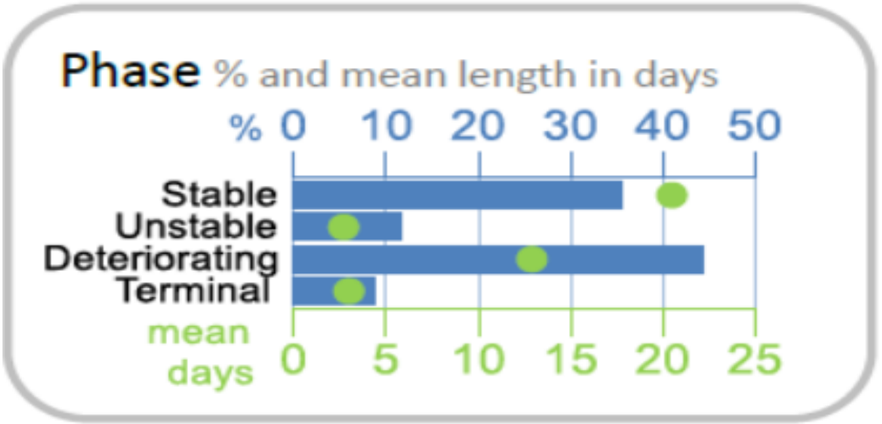
澳洲2020年下半年全國住院資料



Phases per episode

2.2

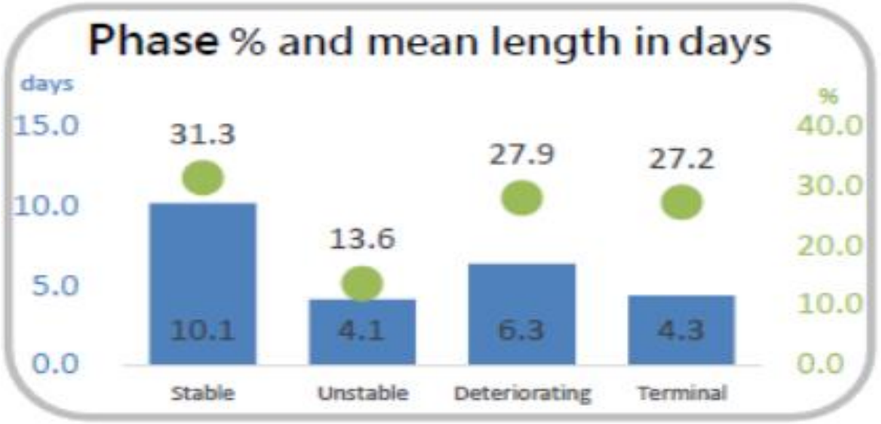
澳洲2020年下半年全國社區資料



Phases per episode

2.2

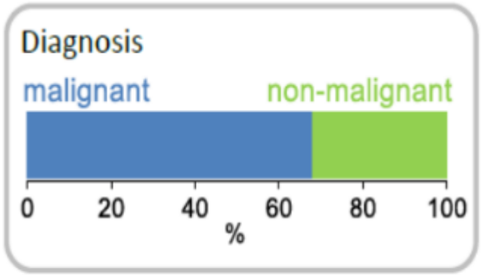
北榮2020年下半年安寧服務資料

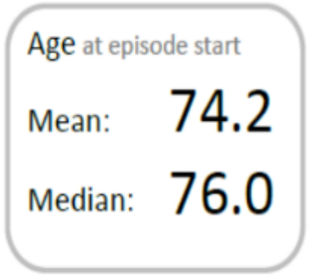


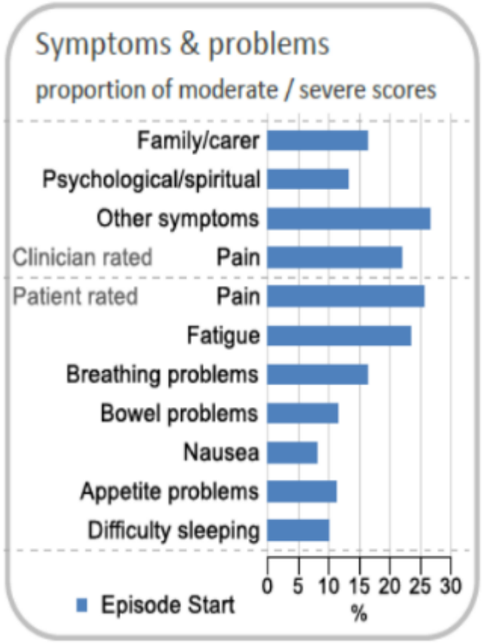
Phases per episode

1.7

澳洲2020年下半年全國住院資料



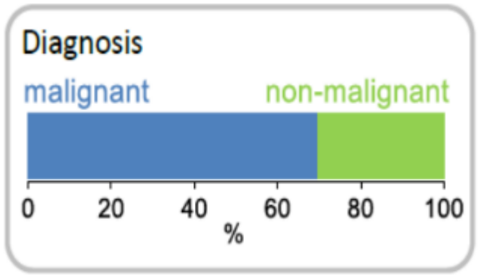


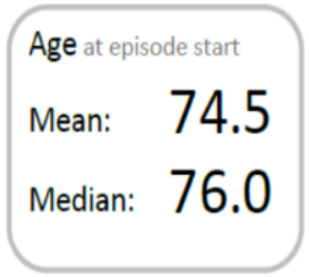


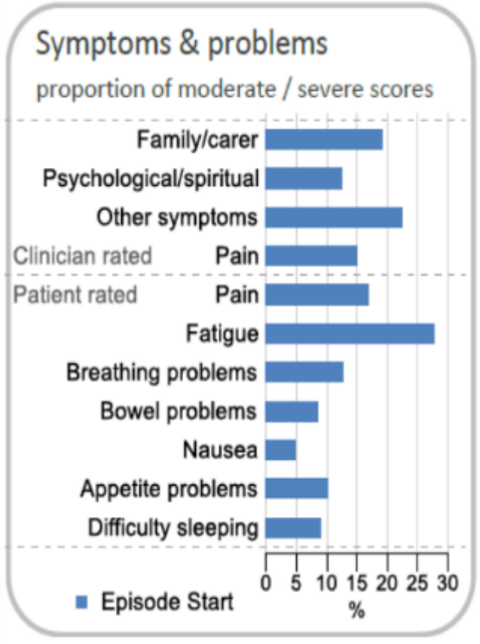




澳洲2020年下半年全國社區資料



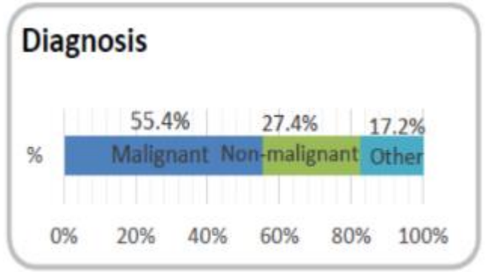


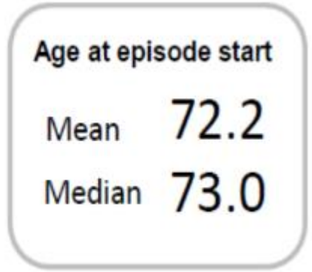


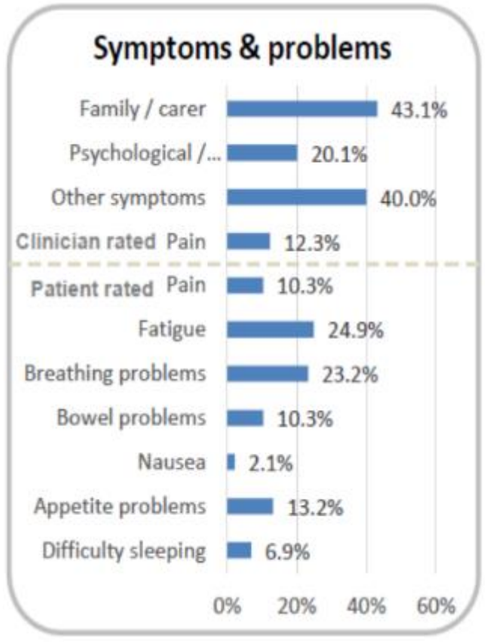


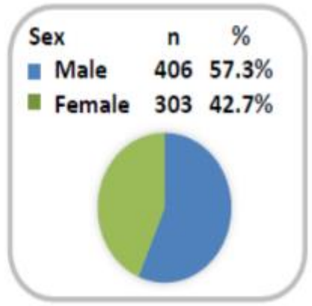


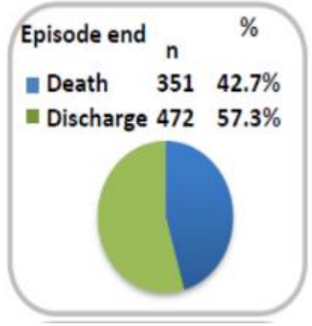
北榮2020年下半年安寧服務資料









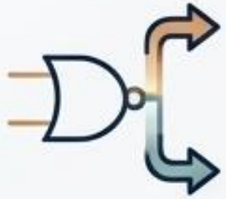


未來趨勢：ePRO 與跳題邏輯的數位整合



數位載體自評
(ePRO)

透過平板、手機或APP，讓病患直接輸入自評結果。



智能跳題邏輯
(Skip Instructions)

系統依據前題答案動態調整。例如：若「無疼痛」，系統自動略過後續疼痛細節問題，極大化減輕疲勞。



電子病歷即時整合
(EHR Integration)

數據零時差自動匯入醫院 HIS 系統。



輔助決策與稽核
(Clinical Decision & Audit)

提供醫療團隊即時數據儀表板，輔助精準給藥、照護決策及臨床品質稽核。

四項條件：克服數位落差、病人身心能力、警示責任歸屬、個資與系統互通性

病人自評結果 (PRO) 的實質力量

PRO 是直接來自病人的測量，不經由臨床人員修改或解釋，真實反映從單一症狀到整體的生活品質。



溝通與症狀控制

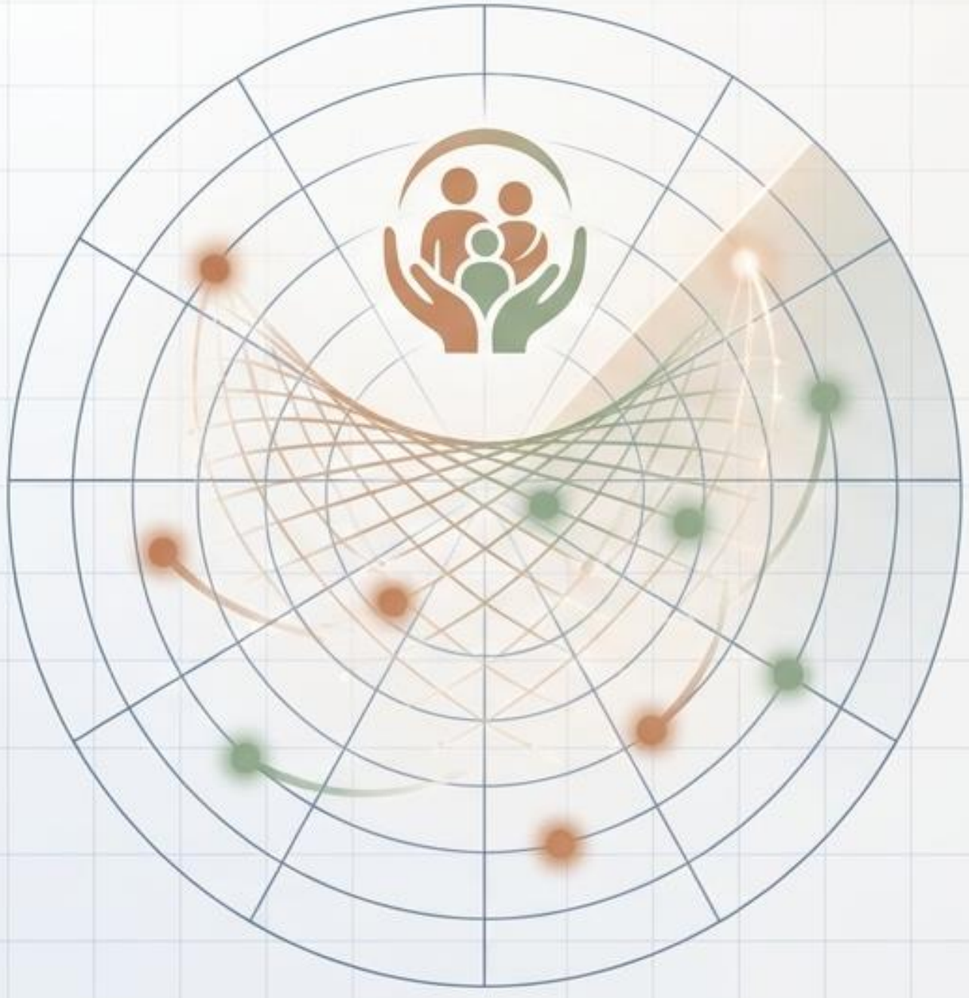
常規使用電子 PRO（ePRO）能顯著改善醫病溝通，提高照護滿意度與症狀控制效率。



生存期與急診率

臨床實證指出，系統性導入 PRO 甚至能「減少急診就診率」並「延長病患生存期」。

稽核的終極目標：從「回溯檢討」到「早期預測」



建立預測模式：

將品質稽核工具應用於末期癌症病患，其核心價值不僅是評分，而是累積龐大的數據庫。

及早辨識 (Early Identification)：

這些稽核數據有助於發展預測模式，使臨床團隊能在危機發生前，及早辨識出可能遭遇困難的病患或家屬。

主動介入：

讓安寧療護從被動的症狀處理，進化為主動的資源轉介與早期介入。

總結：打造專屬於您的安寧照護儀表板



- **日常核心把關**：ESAS / IPOS 是守護常規照護品質的基石。
- **專項問題導向**：BPI, HADS, CAM, DS-II 是精準破解症狀與心理靈性受苦的利器。
- **確保照護完整**：CSNAT, FAMCARE, GDI 讓家屬不再是照護體系中的隱形人。

「評量表的分數僅是起點。真正的品質提升，
來自於團隊將數據轉化為溫暖而精準的臨床行動。」